

Apendicite aguda · diagnóstico e conduta

Dor migratória, anorexia e sinais de irritação em FID ainda são o núcleo. Imagem confirma quando a clínica é dúbia; conduta padrão no adulto típico é apendicectomia.

Quadro clássico

- Dor periumbilical !' FID (ponto de McBurney)
- Anorexia, náusea/vômito após a dor
- Febre baixa a moderada; Blumberg / Rovsing / psoas conforme posição
- Leucocitose com desvio; PCR pode apoiar, não fecha sozinha

Imagem — quando e qual

Cenário | Preferência

Criança / magro / gestante | USG como 1ª linha

Adulto com dúvida | TC com contraste (alta acurácia)

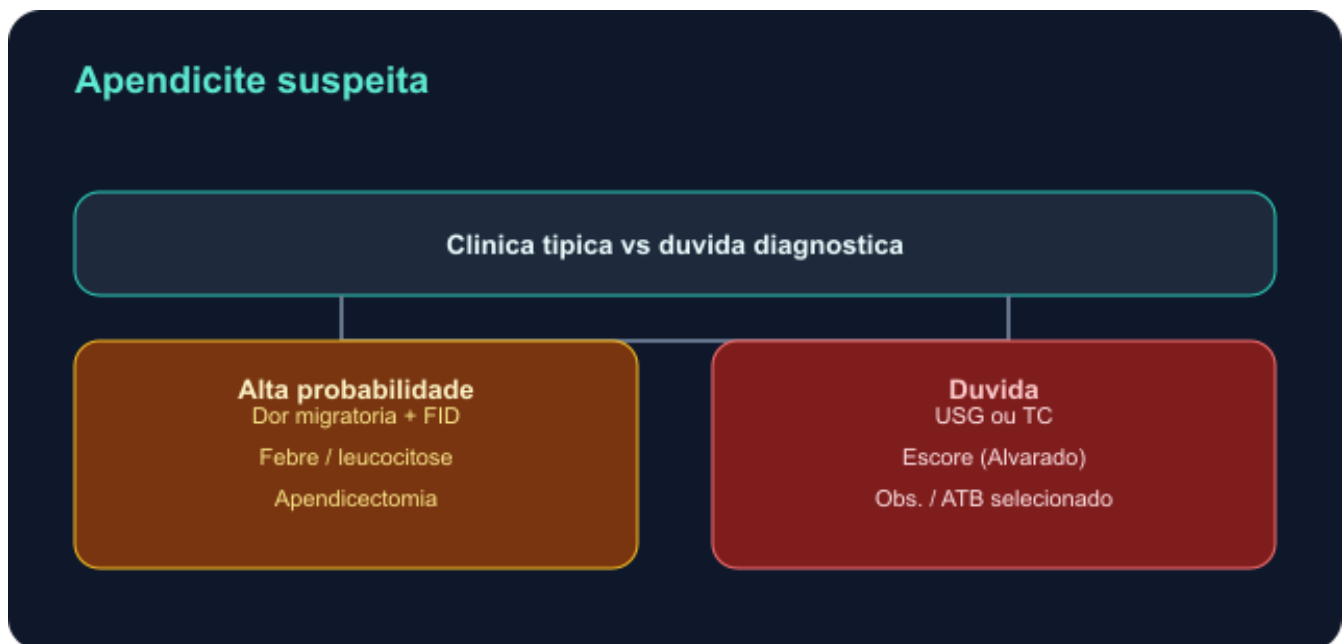
Gestante com USG inconclusivo | RM se disponível

Plastrão / abscesso

Dica - Plastrão / abscesso

Apendicite complicada com plastrão pode receber ATB ± drenagem e apendicectomia intervalada conforme protocolo — não force cirurgia 'a frio' em todo abscesso.

Ramificação de prova: alta probabilidade !' cirurgia; dúvida !' imagem e reavaliação.



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Em idosos e imunossuprimidos a clínica é atípica e a perfuração é mais precoce. Dor 'leve' + sepse abdominal !' imagem e cirurgia sem demora.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Apendicite: clínica + Alvarado/MANTRELS orientam imagem e cirurgia. Corte clássico de escore é ponto alto de prova.

MANTRELS = Migration, Anorexia, Nausea/vomiting, Tenderness FID, Rebound, Elevation temp, Leukocytosis, Shift left.

Alvarado / MANTRELS

Escore 0-10 (pontos)

Migração da dor para FID	1
Anorexia	1
Náusea / vômitos	1
Dor a palpação em FID	2
Rebound / descompressão	1
Febre ($\geq 37,3$ C)	1
Leucocitose (>10.000)	2
Desvio à esquerda (Shift)	1

0-4 improvável | 5-6 possível | 7-10 provável

Interpretação do Alvarado

Lembre - Interpretação do Alvarado

0–4: apendicite improvável (considerar outras causas / observação). 5–6: possível — imagem (USG/TC) ajuda. 7–10: provável — preparar para apendicectomia conforme protocolo local.

Clínica e imagem

Item | Destaque de prova

Dor | Epigástrio/periumbilical !' migra para FID
Sinais | Blumberg, Rovsing, psoas/obturador (retrocecal/pélvico)
USG | 1ª linha em criança/gestante; operador-dependente
TC | Alta acurácia no adulto quando dúvida persiste

Conduta

- Jejum, volume, analgesia, ATB se perfurada/abscesso ou no perioperatório
- Não perfurada: apendicectomia (videolaparoscopia comum)
- Plastrão/abscesso selecionado: ATB $\pm$ drenagem e intervalo conforme caso

Gestante e criança

Dica - Gestante e criança

Útero grávido desloca o apêndice — dor pode ser mais alta. Criança: USG preferencial; evite irradiação desnecessária.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1